

Hérnia · encarcerada vs estrangulada

Hérnia encarcerada não reduz; estrangulada tem comprometimento vascular. Dor intensa, sinais sistêmicos ou irritação peritoneal elevam a urgência para cirurgia imediata.

Clínica de estrangulamento

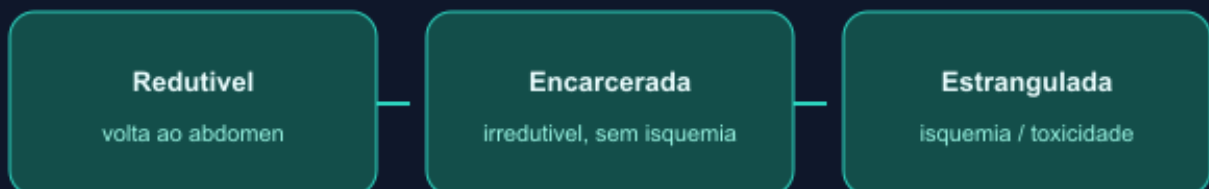
Lembre - Clínica de estrangulamento

Dor desproporcional, pele eritematosa sobre o saco, febre, taquicardia, sinais de obstrução/peritonite ou acidose/lactato!'. Não force tentativas repetidas de redução.

Progressão de prova: irreduzível !' risco de isquemia !' cirurgia urgente se sofrimento.

Espectro da hernia complicada

Redutível -> encarcerada -> estrangulada



Conduta

- Assintomática redutível: eletiva (risco vs benefício; femoral tem alto risco — operar)
- Encarcerada sem sofrimento: tentativa prudente de redução + programação cirúrgica breve
- Estrangulada / peritonite: cirurgia urgente; avaliar vitalidade intestinal
- Femoral e bochadal: maior taxa de estrangulamento — limiar baixo para operar

Tipos que mais caem

Hérnia | Ponto-chave

Inguinal indireta | Lateral aos vasos; comum no jovem

Inguinal direta | Hesselbach; fundo de saco fraco

Femoral | Medial aos vasos; alto risco de estrangular

Incisional | Sobre cicatriz; pode ser ampla / perda de domicílio

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Redução 'bem-sucedida' de hérnia estrangulada pode devolver alça necrosada ao abdome. Se houver sinais de isquemia, vá à cirurgia — não insiste em taxis.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1